La théorie de gestion des symptômes

TD d'application • cas d'Émilie • UE A1 – Semestre 1

Comprendre le vécu d'un symptôme, explorer son contexte, accompagner les stratégies d'autogestion et construire avec la personne des objectifs de soins réalistes.

> **Note de cours**
>
> Ce TD applique les notions présentées dans le CM4 « La théorie dans la pratique » de Stéphanie Pierre (1er octobre 2026). Le cas d'Émilie permet de mobiliser les connaissances dans une situation concrète, sans remplacer le cours de référence.

Objectifs de révision

- Expliquer pourquoi deux personnes peuvent vivre différemment un symptôme comparable.
- Identifier les trois dimensions de la théorie de gestion des symptômes (TGS) et les facteurs contextuels.
- Analyser le cas clinique d'Émilie : éléments de contexte, expérience, groupe de symptômes, autogestion.
- Distinguer la TGS, les 14 besoins de Virginia Henderson et le modèle clinique trifocal.
- Proposer une démarche infirmière fondée sur l'écoute, l'évaluation, la co-construction et le suivi.

> **Priorité explicitement annoncée**
>
> L'intervenante annonce une évaluation universitaire **probablement sous forme de QCM**, avec des **situations à analyser** : identifier les facteurs influençant un symptôme et le vécu de la personne. Elle recommande de connaître la théorie **et** de savoir l'appliquer, y compris en stage. Ce n'est pas l'annonce de questions exactes de partiel.

Sommaire

1. Pourquoi raisonner à partir du symptôme ? 2
2. La TGS : une théorie intermédiaire 3
3. Quatre piliers et facteurs contextuels 4
4. L'expérience du symptôme : trois lectures 4
5. Les symptômes peuvent former un groupe (« cluster ») 5
6. Cas clinique Émilie : données et raisonnement 6
7. Autogestion : ce que fait déjà la personne 6
8. La valeur ajoutée de l'infirmière 7
9. Co-construire des stratégies réalistes 7
10. Trois approches infirmières complémentaires 8
11. Ce que l'enseignante demande de maîtriser 9
12. Pièges QCM / confusions à éviter 10
13. Synthèse générale — L'essentiel du cours 10
14. Définitions et mots-clés 11

1. Pourquoi raisonner à partir du symptôme ?

Le **symptôme** est une expérience vécue par une personne. Il ne se réduit ni à une étiquette diagnostique ni à un score. Une même douleur peut être ressentie et exprimée très différemment selon le parcours de vie, la situation de santé, les émotions, les croyances, le contexte et les ressources disponibles.

Dans le TD, une question de départ distingue le « mal de tête » ressenti d'une **migraine** comme situation clinique pouvant s'accompagner d'autres manifestations. La discussion sert surtout à montrer que nommer un symptôme ne suffit pas : il faut en préciser la nature, le retentissement et le sens pour la personne.

> **À retenir**
>
> **Question infirmière centrale :** « Comment cette personne vit-elle ce symptôme, dans quel contexte, comment y répond-elle et avec quel résultat ? »

Ce que l'infirmière cherche à comprendre

Dimension explorée	Questions utiles
Manifestations	Que ressentez-vous ? Depuis quand ? Comment cela évolue-t-il ?
Importance	À quelle fréquence, quelle intensité, quelle durée ? Quels symptômes associés ?
Signification et vécu	Que pensez-vous de ces symptômes ? Qu'est-ce qui vous inquiète ?
Retentissement	Qu'est-ce que cela change dans les études, le travail, le repos, les relations ?
Ressources / stratégies	Qu'avez-vous essayé ? Qu'est-ce qui aide ou ne suffit plus ?

> **Note de cours**
>
> Le raisonnement clinique commence par le **recueil** et la mise en relation des données, avant la proposition d'interventions. L'intervenante relie cette démarche aux compétences du domaine A : comprendre, définir des interventions, puis réaliser des soins adaptés.

2. La TGS : une théorie intermédiaire

Le CM4 présente la **théorie de gestion des symptômes (TGS)** comme une **théorie intermédiaire**, utile pour comprendre un phénomène infirmier précis et guider la pratique. Elle s'intéresse en particulier à l'expérience individuelle et à la gestion des symptômes, notamment lorsqu'une personne vit avec une maladie chronique.

Elle ne part pas uniquement du diagnostic médical : elle considère le symptôme tel qu'il est **perçu, évalué et vécu**, les efforts mis en place pour le gérer et les résultats obtenus. Les facteurs contextuels influencent tout ce processus.

Trois dimensions complémentaires	Ce qu'il faut en comprendre
1. Expérience du symptôme	Perception, évaluation et réponse / vécu : comment la personne reconnaît, interprète et ressent ses manifestations.
2. Stratégies de gestion	Efforts personnels ou accompagnés visant à prévenir, réduire, retarder ou mieux supporter les symptômes.
3. Résultats de la gestion	Effets observés sur les symptômes et sur la vie quotidienne : fréquence, intensité, retentissement, capacité de gestion, qualité de vie.

> **À retenir**
>
> Les trois dimensions **interagissent** : l'expérience influence les stratégies choisies ; les résultats conduisent à les conserver, les ajuster ou les revoir.

Un symptôme est une expérience individuelle

Deux personnes qui décrivent une intensité douloureuse semblable n'ont pas nécessairement les mêmes émotions, les mêmes antécédents ni les mêmes possibilités d'agir. L'intensité est donc une donnée importante mais **insuffisante à elle seule**.

3. Quatre piliers et facteurs contextuels

Le TD remobilise les quatre piliers du **métaparadigme infirmier** : **personne, environnement, santé/maladie, soin**. Avant de décider quoi faire, l'exercice sur Émilie examine particulièrement les trois premiers : qui est-elle, quelle est sa situation de santé et dans quel environnement vit-elle ?

Pilier	Lecture de la situation d'Émilie
Personne	Étudiante de 22 ans ; expérience ancienne des crises ; perceptions, connaissances, priorités, capacités et habitudes.
Santé / maladie	Migraines récurrentes depuis l'adolescence, crises d'intensité importante, symptômes associés, fréquence récemment augmentée.
Environnement	Études de droit, travail en magasin de surgelés, rythme soutenu, temps devant l'ordinateur, contraintes matérielles et sociales.
Soin	Écoute, recueil de données, sécurité, accompagnement, plan co-construit, orientation et réévaluation.

Facteurs internes et externes : repérer avant de classer

Internes – exemples du TD	Externes – exemples du TD
Fatigue, manque de sommeil, stress ressenti, habitudes, expériences antérieures, peur d'être empêchée de travailler.	Examens, contraintes de la bibliothèque, horaires de travail, lumières et écrans, organisation des études, ressources sociales.

> **Note de cours**
>
> L'enseignante insiste : **ne soyez pas trop rigides sur la case « interne » ou « externe »**. Certaines situations sont mixtes. L'essentiel est de **repérer un facteur, comprendre pourquoi il compte et mettre les éléments en relation**. Une hypothèse (par exemple un facteur déclenchant supposé) ne doit pas devenir un fait établi sans vérification.

4. L'expérience du symptôme : trois lectures

Dans l'expérience du symptôme, l'intervenante propose une lecture en trois questions : **qu'est-ce qui est perçu ? comment est-ce évalué ? comment est-ce vécu / quelle réponse cela suscite-t-il ?** Ces catégories se chevauchent parfois : l'objectif est l'analyse, pas un classement mécanique.

Étape	Dans le cas d'Émilie	Questions de l'infirmière
Perception	Douleur unilatérale au début de la crise, sensation reconnaissable, gêne à la lumière et au bruit, nausées.	« Quels sont les premiers signes ? »
Évaluation	Douleur pulsative, intensité habituelle 7–8/10, comparaison aux crises précédentes, fréquence croissante et gêne fonctionnelle.	« Combien de temps, quelle intensité, à quelle fréquence ? »
Vécu / réponse	Anticipation d'une journée « fichue », inquiétude, effort pour terminer les tâches, stress lié au retard pris.	« Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Que faites-vous quand cela commence ? »

À retenir

Perception = manifestation ressentie ; **évaluation** = appréciation de ses caractéristiques et de sa gravité / conséquence ; **vécu-réponse** = signification, émotions, réactions et comportements. Des recouvrements sont possibles.

Pourquoi le ressenti de la personne modifie l'action

Émilie reconnaît les débuts d'une crise, mais poursuit souvent son activité avant d'interrompre son travail. Son expérience, la pression des études et ses contraintes quotidiennes influencent son comportement. La réponse observée ne se comprend donc qu'en lien avec son contexte.

5. Les symptômes peuvent former un groupe (« cluster »)

Un **cluster de symptômes** désigne plusieurs symptômes qui coexistent, peuvent interagir et contribuer ensemble au retentissement d'une situation. Dans le TD, la migraine ne se réduit pas à la douleur : nausées, gêne à la lumière, gêne au bruit, fatigue, anxiété et difficultés de concentration peuvent composer le vécu global évoqué pour Émilie.

La prise en compte du groupe évite une analyse trop étroite. Réduire l'entretien à « douleur 8/10 » laisse de côté les effets sur le repos, les études, le moral et les stratégies déjà employées.

Application à Émilie

Le raisonnement du TD décrit une **boucle d'auto-entretien** : périodes d'examen → rythme modifié, repas sautés et fatigue → crises plus gênantes → travail perturbé et stress accru → difficulté à retrouver un rythme compatible avec ses besoins. Il s'agit d'une **lecture de la situation**, pas d'une relation de causalité automatiquement prouvée pour chaque facteur.

Ce que change la lecture en cluster

- Interroger plusieurs manifestations et leur retentissement combiné.
- Identifier les interactions possibles sans confondre association et preuve de causalité.
- Choisir des critères de suivi qui ne se limitent pas à une note de douleur.
- Repérer les limites de l'autogestion et la nécessité éventuelle d'un avis médical.

6. Cas clinique Émilie : données et raisonnement

Émilie, 22 ans, est en troisième année de licence de droit et travaille en parallèle pour financer ses études. Elle présente des migraines récurrentes depuis l'adolescence, habituellement une à deux crises par mois, avec une douleur pulsative importante, parfois des nausées, et une sensibilité à la lumière ou au bruit. Les crises perturbaient déjà ses activités. Depuis quelques semaines, leur fréquence augmente ; au cours d'un mois, elle rapporte cinq crises. Elle consulte l'infirmière universitaire.

Les exemples d'un sommeil raccourci, de repas du midi sautés et de longues périodes devant l'ordinateur sont explorés avec elle. Ces éléments constituent des pistes de compréhension et de suivi, non une preuve isolée de la cause de ses migraines.

Faits donnés	Interprétation infirmière prudente / donnée à compléter
Crises plus fréquentes qu'avant	Changement d'évolution : nécessite une réévaluation clinique et une orientation adaptée, pas la simple répétition de conseils usuels.
Douleur intense et autres manifestations	Explorer nature, durée, fréquence, signes associés et retentissement ; rester attentif aux signes d'alerte.
Rythme études + emploi	Comprendre les contraintes réelles avant de proposer un changement.
Crises parfois anticipées mais travail poursuivi	Rechercher ses objectifs, ses représentations et les raisons de cette réponse.
Stratégies antérieures devenues insuffisantes	Identifier ce qui aide encore, ce qui ne suffit plus et les ressources à mobiliser.

> **Attention**
>
> L'exemple illustre le **raisonnement infirmier**, pas un diagnostic médical à distance. Une modification du profil de céphalées ou des signes préoccupants justifient une évaluation / orientation selon la situation et les procédures applicables. Le TD rappelle de ne pas dépasser son champ de compétences.

7. Autogestion : ce que fait déjà la personne

Avant la consultation, Émilie a développé des **stratégies d'auto-soins** : arrêter l'ordinateur, s'isoler du bruit et de la lumière, se reposer ou tenter de dormir, boire et utiliser son traitement de crise tel qu'il a été prescrit. Elle reconnaît plusieurs de ses signes habituels.

La question n'est pas « fait-elle tout bien ? », mais **quelles stratégies utilise-t-elle, quand, pourquoi, et avec quels effets ?** Dans ce cas, elle peut poursuivre trop longtemps son activité et ses stratégies habituelles ne suffisent plus à limiter le retentissement.

Autonomie ne signifie pas automédication

Le TD distingue l'**autonomie dans l'application d'une prescription connue** de l'**automédication**. Une personne peut savoir utiliser de façon autonome un traitement prescrit, après une information adaptée, sans être pour autant libre d'en changer les modalités.

Pour une prescription « si besoin », l'infirmière doit respecter la prescription, les conditions d'administration, l'évaluation du besoin et le périmètre de compétences. Aucune posologie ni recommandation médicamenteuse nouvelle n'est tirée de ce cas.

> **À retenir**
>
> Une stratégie d'autogestion est un **effort concret pour prévenir ou atténuer un symptôme**. Elle peut être personnelle ou soutenue par un professionnel. Son intérêt se juge sur son adéquation et ses résultats, non sur sa seule existence.

8. La valeur ajoutée de l'infirmière

L'infirmière aide Émilie à sortir d'un engrenage qu'elle peine à analyser seule. Elle **écoute, explore, structure, relie** les données et accompagne la recherche de solutions. L'entretien débute par le récit de la crise, et non par une liste de prescriptions de comportement.

Étape clinique	Application au cas
1. Écouter	Inviter à raconter le déroulement d'une crise et ses répercussions, sans minimiser le vécu.
2. Évaluer	Fréquence, intensité, durée, manifestations associées, évolution, contexte, sommeil, repas, stress, ressources et signes d'alerte.
3. Mettre en relation	Rechercher avec Émilie des régularités sans affirmer trop vite une cause.
4. Co-construire	Sélectionner ensemble un changement faisable et acceptable dans sa vie d'étudiante salariée.
5. Suivre et ajuster	Réévaluer le retentissement et les résultats, revoir les objectifs ou orienter si nécessaire.

Le carnet de suivi

L'enseignante propose, à titre d'exemple, un **carnet de suivi** dans lequel la personne note les crises, leur contexte, leur intensité et les habitudes associées. Le carnet peut aider à repérer des liens possibles entre rythme de vie et manifestations, puis à discuter des stratégies avec la patiente.

> **Note de cours**
>
> Une observation répétée dans un carnet aide à **formuler une hypothèse clinique** ; elle n'autorise pas, à elle seule, à affirmer une relation causale ou à écarter un problème médical. L'évaluation de sécurité et l'orientation restent essentielles.

9. Co-construire des stratégies réalistes

L'intervenante critique volontairement le conseil général et irréaliste (« dormez plus, mangez mieux, stressez moins ») lorsqu'il ne tient pas compte de la vie de la personne. Un objectif imposé peut être inapplicable, décourageant et dégrader la confiance.

Dans le TD, l'infirmière invite Émilie à choisir parmi plusieurs possibilités. La patiente retient des changements à sa portée, comme **ne plus sauter le déjeuner** et **faire une pause lors de longues séances de travail**. La démarche est une **négociation** : elle conserve ses objectifs universitaires et professionnels tout en identifiant des ajustements réalisables.

> **Priorité explicitement annoncée**
>
> Point oral fortement souligné : le projet de soins est **co-construit**. L'adhésion ne consiste pas à obtenir l'obéissance du patient, mais à rechercher une stratégie **comprise, acceptée et réellement réalisable**. La personne reste actrice de ses choix.

Objectifs et résultats : deux niveaux différents

Objectif / moyen négocié	Résultat recherché et évalué
Prendre un repas sur les journées à la bibliothèque ; prévoir des pauses compatibles avec les révisions.	Diminuer si possible la fréquence et/ou l'intensité des crises ; limiter leur retentissement sur les études et le quotidien.
Maintenir un suivi et solliciter un avis adapté lorsque les stratégies ne suffisent pas.	Mieux comprendre les épisodes, renforcer les capacités d'autogestion et améliorer la qualité de vie.

Le TD insiste sur le fait qu'**une disparition complète et immédiate de tout symptôme n'est pas toujours un objectif réaliste** dans une situation chronique. L'évaluation peut porter sur une diminution de fréquence, d'intensité, de gêne ou sur une meilleure capacité à faire face. Il faut définir des critères adaptés puis les réévaluer.

> **À retenir**
>
> Une stratégie peut être revue : **recueillir → comprendre → négocier → mettre en œuvre → évaluer → ajuster**. Le suivi fait partie intégrante du raisonnement.

10. Trois approches infirmières complémentaires

Le TD rapproche trois outils étudiés en UE A1. Ils n'entrent pas en concurrence : chacun éclaire la même situation sous un angle différent. Le CM4 officiel les distingue explicitement.

Approche	Question principale	Ce qu'elle apporte dans le cas d'Émilie
14 besoins de Virginia Henderson Modèle conceptuel	Quels besoins et quelle autonomie sont affectés ?	Repère les difficultés de repos, d'alimentation, de travail et les besoins de soutien / suppléance.
Théorie de gestion des symptômes Théorie intermédiaire	Comment les symptômes sont-ils ressentis et gérés ?	Explore le vécu, les facteurs contextuels, les stratégies et leurs résultats.
Modèle clinique trifocal Modèle clinique	Comment structurer les données pour juger ?	Classe situation de santé / manifestations, risques potentiels et réactions humaines réelles.

Le modèle clinique trifocal en trois axes

• **Axe 1 — Situation de santé / signes et symptômes de la pathologie ou du handicap :** données qui décrivent le problème médical et ses manifestations.

• **Axe 2 — Risques et complications potentielles :** éléments à anticiper sur la base des informations recueillies, sans les déclarer déjà présents.

• **Axe 3 — Réactions humaines réelles :** répercussions physiques, psychologiques ou sociales effectivement rapportées ou observées.

> **Note de cours**
>
> Le TD précise que le modèle trifocal sera développé plus largement au semestre 2. Ici, il s'agit d'un **repère comparatif** et non d'une analyse exhaustive ou d'un diagnostic infirmier complet.

11. Ce que l'enseignante demande de maîtriser

Priorités explicitement formulées pendant le TD

• Retenir les **14 besoins fondamentaux** de Virginia Henderson avant le stage, pour structurer le recueil de données.

• Comprendre la **théorie de gestion des symptômes**, pas seulement apprendre son nom.

• Savoir **analyser une situation** en identifiant facteurs d'influence, perception, évaluation, vécu, stratégies et résultats.

• Ne pas être **excessivement rigide** dans la catégorisation de données qui interagissent.

• Construire des propositions **réalistes et négociées** avec la personne ; préserver son adhésion.

Priorités déduites des exercices et de la structure du cours

• Reconnaître un groupe de symptômes et les conséquences d'une lecture trop limitée à l'intensité.

• Savoir dire en quoi les trois approches — Henderson, TGS, trifocal — sont complémentaires.

• Différencier un fait donné, une hypothèse de contexte, un risque et une réaction humaine réelle.

• Proposer au moins un critère de réévaluation cohérent avec l'objectif choisi.

> **Application à Émilie**
>
> **Mini-application :** Émilie rapporte cinq crises ce mois-ci au lieu d'une ou deux habituellement. Une réponse attendue n'est pas « elle doit simplement se détendre », mais une **évaluation du changement**, de son retentissement et des signes associés, puis une démarche adaptée associant sécurité, discussion des stratégies et orientation si nécessaire.

12. Pièges QCM / confusions à éviter

Confusion	Correction à retenir
« Migraine = uniquement douleur à la tête »	L'expérience peut inclure d'autres manifestations et un retentissement global.
« Même intensité = même vécu »	Le vécu dépend aussi de la personne, de son histoire et du contexte.
« Une note 8/10 suffit à tout analyser »	Il faut explorer caractéristiques, signes associés, évolution et conséquences.
« Facteur interne/externe : une seule case possible »	Le contexte est interactif et le classement ne doit pas masquer les liens.
« Cluster = une complication nécessaire »	Un cluster est un **groupe de symptômes**, pas une complication.
« L'autonomie est forcément de l'automédication »	On peut utiliser de façon autonome un traitement prescrit, selon les modalités prévues.
« Adhésion = suivre sans discuter un plan imposé »	L'adhésion s'appuie sur une décision comprise, acceptée et faisable.
« Définir un conseil suffit »	Il faut co-construire, suivre les effets et réévaluer.
« Un risque est déjà un problème réel »	Le trifocal distingue les risques potentiels des réactions présentes.
« TGS, Henderson et trifocal sont interchangeables »	Ils répondent à des questions complémentaires.

13. Synthèse générale — L'essentiel du cours

La **TGS** est une théorie intermédiaire qui aide à comprendre l'expérience individuelle des symptômes. Elle met en relation **expérience, stratégies de gestion et résultats**, en tenant compte des facteurs liés à la **personne, la santé et l'environnement**.

L'expérience du symptôme s'explore par la **perception, l'évaluation et le vécu/réponse**. Plusieurs manifestations peuvent former un **cluster**. Le cas d'Émilie montre comment des migraines récurrentes, leurs symptômes associés et la pression du quotidien peuvent s'influencer réciproquement.

L'infirmière ne se contente pas d'un score ni de conseils généraux : elle écoute, évalue, met les données en relation, repère les limites de l'autogestion, construit avec la personne un plan **acceptable et réaliste**, puis en **réévalue** les résultats. La sécurité et l'orientation sont à apprécier selon les données cliniques.

Les **14 besoins** éclairent l'autonomie, la **TGS** le vécu et la gestion des symptômes, et le **trifocal** la structuration du jugement clinique. Pour les examens et les stages, il faut pouvoir appliquer ces trois regards à une situation.

14. Définitions et mots-clés

Terme	Définition pour réviser et les vocaux
Symptôme	Manifestation ressentie par une personne ; son expérience et sa signification peuvent être subjectives.
Théorie de gestion des symptômes (TGS)	Théorie intermédiaire qui relie expérience du symptôme, stratégies de gestion, effets obtenus et facteurs contextuels.
Théorie intermédiaire	Théorie centrée sur un phénomène infirmier précis, entre les conceptions très générales et les situations concrètes.
Métaparadigme infirmier	Quatre piliers de lecture de la discipline : personne, environnement, santé/maladie et soin.
Perception	Ce que la personne ressent ou reconnaît comme manifestation.
Évaluation du symptôme	Appréciation de la fréquence, intensité, durée, évolution, retentissement et signification de la manifestation.
Vécu / réponse au symptôme	Émotions, interprétations et réactions associées à l'expérience du symptôme.
Facteurs contextuels	Caractéristiques personnelles, de santé ou d'environnement qui influencent l'expérience et la gestion.
Facteur interne	Élément situé du côté de la personne : émotions, histoire, habitudes, ressources propres ; distinction parfois non stricte.
Facteur externe	Élément de contexte lié à l'environnement : travail, études, contraintes, réseau de soutien ; distinction parfois non stricte.
Interaction	Influence réciproque entre plusieurs facteurs, expériences ou réponses.
Cluster de symptômes	Groupe de symptômes coexistants, susceptibles d'interagir et de créer un retentissement commun.
Autogestion	Actions par lesquelles une personne participe à la gestion de sa situation de santé et de ses symptômes.
Auto-soins	Mesures mises en œuvre par la personne pour prendre soin d'elle dans les limites de ses connaissances et prescriptions.
Automédication	Prise d'un médicament de sa propre initiative, distincte de l'usage autonome d'un traitement prescrit.
Stratégie de gestion	Action visant à prévenir, minimiser, retarder ou mieux supporter le symptôme.
Résultat de la gestion	Effet évalué d'une stratégie sur les symptômes, les capacités et la qualité de vie.

Terme	Définition pour réviser et les vocaux
Adhésion	Participation de la personne à un projet de soin qu'elle comprend, accepte et juge réalisable.
Co-construction	Élaboration du plan de soins avec la personne plutôt que sa simple imposition.
Négociation thérapeutique	Recherche d'un compromis acceptable entre les besoins de santé et les priorités de la personne.
Objectif réaliste	But atteignable dans la situation réelle de la personne, assorti de critères vérifiables.
Réévaluation	Nouvelle appréciation des symptômes, des résultats et de l'adéquation du plan après mise en œuvre.
Cahier / carnet de suivi	Support consignant épisodes, contexte, manifestations et effets des stratégies afin d'en discuter les tendances.
14 besoins fondamentaux	Modèle conceptuel de Virginia Henderson centré sur besoins quotidiens et autonomie.
Modèle clinique trifocal	Organisation des données en situation de santé / manifestations, risques potentiels et réactions humaines réelles.
Risque potentiel	Problème possible à anticiper ; il n'équivaut pas à une manifestation effectivement présente.
Réaction humaine réelle	Réponse physique, psychologique ou sociale observée ou rapportée dans la situation.
Raisonnement clinique	Recueil, interprétation et mise en relation de données pour orienter une décision de soin.
Jugement clinique	Appréciation argumentée d'une situation fondée sur les données pertinentes et les connaissances mobilisées.
Retentissement fonctionnel	Conséquence des symptômes sur les activités et la vie quotidienne.